



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Ciclos de Vida

Pré-natal · Parto e puerpério · Aleitamento · Planejamento
familiar · Aborto legal
Criança · Adolescente · Adulto · Idoso

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

Calendário e protocolos conferidos · Ministério da Saúde, versão 2026

O eixo que mais se atualiza

Aqui está o conteúdo que mais muda de um ano para o outro — e é justamente por isso que ele separa quem estudou por material velho de quem estudou pelo atual.

O calendário vacinal se atualiza todo ano; a caderneta da gestante e da criança são revisadas; novas vacinas entram no SUS. Este ebook foi construído sobre o **Calendário Nacional de Vacinação 2026** e os protocolos vigentes do Ministério da Saúde — e sinaliza, ao longo do texto, o que mudou.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Gestante** — pré-natal, vacinação, parto e puerpério.
- ◆ **Aleitamento materno** — tipos, técnica, contraindicações.
- ◆ **Criança** — calendário vacinal 2026, triagem neonatal, crescimento.
- ◆ **Planejamento familiar e aborto legal.**
- ◆ **Adolescente, adulto e idoso.**

Aviso importante sobre este eixo

O Calendário Nacional de Vacinação é **revisado anualmente** e há mudanças relevantes de um ano para o outro. Este material segue a versão **2026**. Confirme sempre o calendário do ano no site do Ministério da Saúde antes da prova — e desconfie de material antigo, que é o erro mais comum de quem estuda por apostila desatualizada.

Sumário

1 Pré-natal

Consultas e exames

Vacinação da gestante

Sinais de alerta

2 Parto e puerpério

Fases do parto

Cuidados no puerpério

3 Aleitamento materno

Tipos e composição

Técnica e pega

Contraindicações

4 Saúde da criança

Calendário vacinal 2026

Triagem neonatal

Crescimento

5 Planejamento familiar e aborto legal

Métodos

Critérios legais

6 Adolescente, adulto e idoso

Particularidades

Avaliação do idoso

7 Síntese e bizzus finais

Revisão rápida

1

Pré-natal

O acompanhamento que salva duas vidas. E que o enfermeiro pode conduzir.

1 · Consultas e rotina

O Ministério da Saúde recomenda **no mínimo 6 consultas** de pré-natal, iniciando **no primeiro trimestre**, com esta distribuição:

Caderneta da Gestante · Guia de Atenção à Saúde da Gestante · Ministério da Saúde

ITEM	PARÂMETRO
Mínimo de consultas	6: 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo, 3 no terceiro.
Periodicidade	Até 28 semanas: mensal. De 28 a 36 semanas: quinzenal. Após 36 semanas: semanal.
Intervalo máximo	Não deve ultrapassar 8 semanas entre consultas.
Alta do pré-natal	Não existe. O acompanhamento vai até o parto.

BIZU ESTRATÉGICO

Ponto de ouro para o enfermeiro: a **consulta de pré-natal de risco habitual pode ser realizada pelo enfermeiro**, de forma intercalada com o médico. O enfermeiro solicita e interpreta os exames de rotina, preenche a caderneta e estratifica o risco. Enunciado que restringe o pré-natal ao médico está errado.

◆ Exames de rotina

SOLICITADOS NA PRIMEIRA CONSULTA

- ◆ Hemograma · tipagem sanguínea e fator Rh · glicemia de jejum.
- ◆ Sorologias: **sífilis (VDRL)**, **HIV**, **hepatite B (HBsAg)**, **toxoplasmose (IgG/IgM)**.
- ◆ Sumário de urina (EAS) e **urocultura** — rastreio de bacteriúria assintomática.
- ◆ Repetir no **3º trimestre** (28–30 semanas): hemograma, VDRL, HIV, urocultura, glicemia.
- ◆ **Estreptococo do grupo B**: cultura anovaginal entre **35 e 37 semanas**.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que se rastreia **bacteriúria assintomática** na gestante — e só nela: fora da gravidez, bactéria na urina sem sintoma não se trata. Na gestação, sim — porque as alterações fisiológicas (dilatação ureteral, estase urinária pela progesterona) fazem essa bacteriúria evoluir para **pielonefrite** em até 30% dos casos, com risco de trabalho de parto prematuro. Rastrear e tratar o assintomático, aqui, previne desfecho grave.

HEMOGLOBINA

CONDUTA

Hemoglobina ≥ 11 g/dL

Normal. Profilaxia com ferro elementar e ácido fólico.

Hb entre 8 e 11 g/dL

Anemia leve a moderada. Tratar, investigar parasitose, repetir em 30–60 dias.

Hb ≤ 8 g/dL

Anemia grave. **Encaminhar ao pré-natal de alto risco.**

BIZU ESTRATÉGICO

Suplementação: **ácido fólico** idealmente *antes* da concepção e no 1º trimestre (previne defeitos do tubo neural) e **ferro** a partir da 20ª semana. A prova cobra o *porquê* do folato ser pré-concepcional: o tubo neural fecha por volta da 4ª semana — quando muitas mulheres nem sabem que estão grávidas.

1 · Vacinação da gestante — 2026

Aqui está uma das maiores atualizações recentes do calendário. As vacinas de rotina na gestação:

Calendário Nacional de Vacinação — Gestante · Ministério da Saúde, 2026

VACINA	ESQUEMA
dTpa	1 dose a partir da 20ª semana, em cada gestação. Protege o bebê contra coqueluche nos primeiros meses.
Influenza	1 dose por temporada, em qualquer idade gestacional.
Hepatite B	3 doses, conforme histórico vacinal.
dT	3 doses, conforme histórico vacinal.
Covid-19	1 dose a cada gestação.
VSR (Vírus Sincial Respiratório)	NOVIDADE. 1 dose em cada gestação. Protege o recém-nascido contra bronquiolite e pneumonia.
Febre amarela	Apenas em casos excepcionais (área de risco), após avaliação — é vírus vivo.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica da **vacinação da gestante**: ela protege *duas* pessoas. Os anticorpos maternos atravessam a placenta e conferem **imunidade passiva** ao bebê nos primeiros meses — justamente a janela em que ele ainda não pode receber as próprias vacinas. É por isso que a dTpa é dada **em toda gestação**, mesmo que a mulher já tenha tomado antes: o objetivo não é (só) protegê-la, é *transferir anticorpo fresco* para aquele bebê.

PEGADINHA CLÁSSICA

Atenção à divergência de fontes sobre a VSR. A página do Calendário Nacional traz “a partir da 28ª semana”; a Caderneta da Gestante e materiais de capacitação trazem “entre 32 e 36 semanas”. Trata-se de vacina de incorporação recente, com recomendação em ajuste. **Confirme a janela na versão vigente do calendário antes da prova** — e, se o enunciado citar a fonte, siga a fonte citada.

PEGADINHA CLÁSSICA

Vacinas de **vírus vivo** são **contraindicadas** na gestação: tríplice viral (SCR), varicela, febre amarela (salvo risco excepcional avaliado). A febre amarela é a exceção que a banca adora: *pode* ser feita se o risco de adoecer superar o risco da vacina.

◆ Sinais de alerta na gestação

CAI EM PROVA

- ◆ Sangramento vaginal em qualquer fase.
- ◆ Perda de líquido (suspeita de rotura de membranas).
- ◆ Cefaleia intensa, escotomas, epigastralgia — sinais de pré-eclâmpsia grave.
- ◆ Redução dos movimentos fetais.
- ◆ Febre, dor ao urinar, contrações antes de 37 semanas.

BIZU ESTRATÉGICO

A tríade que indica iminência de eclâmpsia: cefaleia + distúrbio visual (escotomas) + epigastralgia. Esses três, numa gestante hipertensa, significam **emergência** — não é enxaqueca, é sinal de que a convulsão está próxima. O sulfato de magnésio é o fármaco de escolha para prevenir e tratar a eclâmpsia.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Na **administração de sulfato de magnésio**, a enfermagem monitora três coisas — e a prova cobra as três: **reflexo patelar** (o primeiro a desaparecer na intoxicação), **frequência respiratória** (≥ 16 irpm) e **diurese** ($\geq 25\text{--}30$ mL/h, porque o magnésio é excretado pelo rim). O antídoto é o **gluconato de cálcio**.

2

Parto e puerpério

As fases do parto e o que vigiar depois. Hemorragia é a campeã de mortalidade.

2 · Fases do trabalho de parto

PERÍODO	DEFINIÇÃO
1º período — Dilatação	Do início das contrações rítmicas até a dilatação completa (10 cm). É o mais longo.
2º período — Expulsivo	Da dilatação total até a saída do bebê.
3º período — Dequitação	Saída da placenta (secundamento).
4º período — Greenberg	Primeira hora após a dequitação. Período de maior risco de hemorragia.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o 4º período (Greenberg) é o mais perigoso: após a saída da placenta, o útero precisa **contrair** para comprimir os vasos do leito placentário — é a chamada “ligadura viva de Pinard”. Se o útero não contrai (**atonía uterina**), esses vasos ficam abertos e a mulher sangra rápido. Por isso a enfermagem palpa o fundo uterino nessa primeira hora: **útero contraído = globo de segurança de Pinard**; útero amolecido = alerta máximo.

BIZU ESTRATÉGICO

A causa mais comum de hemorragia pós-parto é a **atonía uterina**. Primeira conduta da enfermagem: **massagem uterina** e avaliação do globo de segurança, com acesso venoso e ocitocina conforme prescrição. Mnemônico das causas — os 4 T: **T**ônus (atonía), **T**rauma (lacerações), **T**ecido (restos placentários), **T**rombina (coagulopatia).

◆ Puerpério

FASE	PERÍODO
Imediato	1º ao 10º dia.
Tardio	11º ao 42º dia.
Remoto	A partir do 43º dia.

BIZU ESTRATÉGICO

Loquiação — a prova cobra a **cor pela fase: rubra** (vermelha, até ~3-4 dias) → **serosa** (rosada/acastanhada) → **alba** (branco-amarelada). Loquiação com **odor fétido** sugere **infecção puerperal**; retorno de sangramento vivo tardio é alerta.

3

Aleitamento materno

O tema mais cobrado da saúde da criança — e o mais cheio de definição exata.

3 · Tipos de aleitamento

As definições da OMS/Ministério da Saúde são cobradas **literalmente**. A diferença entre elas está em *o que mais a criança recebe*:

TIPO	DEFINIÇÃO
Exclusivo	Só leite materno (direto da mama ou ordenhado). Permite apenas gotas/xaropes de vitaminas, sais de reidratação e medicamentos. Nem água .
Predominante	Leite materno + líquidos (água, chás, sucos). Sem outro leite.
Complementado	Leite materno + alimentos sólidos/semissólidos , para complementar.
Misto ou parcial	Leite materno + outro leite .

BIZU ESTRATÉGICO

A chave para não errar: o **exclusivo** não admite **nem água**. Se entrou água ou chá → virou **predominante**. Se entrou comida → **complementado**. Se entrou *outro leite* → **misto**. Recomendação: **exclusivo** até 6 meses e **complementado** até 2 anos ou mais.

◆ Composição do leite

TIPO	CARACTERÍSTICA
Colostro	Primeiros dias. Rico em proteínas e imunoglobulinas (IgA) , pobre em gordura. Volume pequeno — e suficiente.
Leite de transição	Entre o colostro e o maduro.
Leite maduro	A partir de ~2 semanas. Mais gordura e lactose.
Leite anterior × posterior	O anterior (início da mamada) é mais aguado, mata a sede. O posterior (fim) é rico em gordura e dá saciedade e ganho de peso.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que se deve **esvaziar uma mama antes de oferecer a outra**: a gordura aumenta ao longo da mamada. Se a mãe troca de peito cedo, o bebê recebe muito leite *anterior* (aguado, rico em lactose) e pouco *posterior* — resultado: mama o tempo todo, não ganha peso e pode ter cólica e fezes esverdeadas por sobrecarga de lactose. O problema não é “leite fraco”: é manejo.

◆ Pega correta

OS SINAIS DE PEGA ADEQUADA

- ◆ Boca **bem aberta**, abocanhando a **aréola** — não só o mamilo.
- ◆ **Lábio inferior evertido** (virado para fora).
- ◆ **Queixo tocando a mama**.
- ◆ Mais aréola visível **acima** da boca que abaixo.
- ◆ Bochechas arredondadas; sucção lenta e profunda, com deglutição audível.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a pega errada causa **fissura**: se o bebê pega só o mamilo, ele comprime a ponta contra o palato duro, em vez de ordenhar os seios lactíferos sob a aréola. Resultado: dor, trauma e — como não drena bem — **ingurgitamento**, que pode evoluir para **mastite**. Quase todo problema da amamentação começa na pega. Por isso a conduta nº 1 diante de fissura é **corrigir a pega**, não suspender a mamada.

PEGADINHA CLÁSSICA

Na **mastite**, a conduta é **manter a amamentação** (o esvaziamento é parte do tratamento), com antibiótico se indicado. A banca oferece “suspender a amamentação na mama afetada” — errado, isso piora a estase. Só se interrompe temporariamente em situações específicas, como abscesso drenando na papila.

◆ Contraindicações

SITUAÇÃO	CONDUTA
Definitivas (maternas)	HIV e HTLV. No Brasil, mãe com HIV não amamenta e recebe fórmula pelo SUS.
Definitivas (do bebê)	Galactosemia — erro inato do metabolismo.
Temporárias	Herpes com lesão <i>na mama</i> , varicela materna próxima ao parto, uso de alguns fármacos (quimioterápicos, radiofármacos).
NÃO contraindicam	Hepatite B e C, tuberculose (mãe em tratamento, com máscara), dengue, mastite, febre, gripe, covid-19 (com precauções).

PEGADINHA CLÁSSICA

Decore as contraindicações **definitivas: HIV, HTLV e galactosemia**. A banca lista hepatite B, tuberculose ou mastite como se contraindicassem — **não contraindicam**. Na tuberculose, a mãe em tratamento amamenta usando máscara.

4

Saúde da criança

Calendário 2026, triagem neonatal e crescimento. Aqui é onde o material velho mais engana.

4 · Calendário vacinal 2026 — criança

Este é o quadro **vigente**. Compare com o que você estudou: há mudanças que derrubam quem usa material antigo.

Calendário Nacional de Vacinação — Criança · Ministério da Saúde, 2026

IDADE	VACINAS
Ao nascer	BCG (dose única) e Hepatite B (1 dose).
2 meses	Penta (1ª), VIP (1ª), Pneumo 10 (1ª), Rotavírus (1ª).
3 meses	Meningocócica C (1ª).
4 meses	Penta (2ª), VIP (2ª), Pneumo 10 (2ª), Rotavírus (2ª).
5 meses	Meningocócica C (2ª).
6 meses	Penta (3ª), VIP (3ª), Influenza, Covid-19.
9 meses	Febre amarela (1ª).
12 meses	Pneumo 10 (reforço), Meningocócica ACWY, Tríplice viral (1ª).
15 meses	DTP (1º reforço), VIP (1º reforço), Tríplice viral (2ª), Varicela, Hepatite A.
4 anos	DTP (2º reforço), Febre amarela (reforço), Varicela.
9 a 14 anos	HPV4 — dose única.
10 a 14 anos	Dengue (2 doses).
11 a 14 anos	Meningocócica ACWY (1 dose).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O que mudou — e o material antigo ainda ensina errado:

- Aos **12 meses**, entra a **meningocócica ACWY** (protege contra A, C, W e Y), no lugar do antigo reforço de meningo C. Há também dose de ACWY dos **11 aos 14 anos**.
- **HPV**: passou a ser **dose única**, de **9 a 14 anos** — antes eram 2 doses.
- **Dengue** entrou no calendário: **10 a 14 anos**, 2 doses.
- **Covid-19** integra o calendário infantil (a partir dos 6 meses) e é **semestral no idoso**.
- **Influenza** hoje é **trivalente** (não quadrivalente).
- A **pentavalente** substituiu a antiga tetravalente há anos — se sua apostila diz “tetra aos 2-4-6 meses”, ela está velha.

BIZU ESTRATÉGICO

O bloco **2-4-6 meses** continua sendo o mais cobrado: **Penta + VIP** nos três; **Pneumo 10** e **Rotavírus** apenas aos 2 e 4. E a **meningo C** anda “fora do ritmo”, aos **3 e 5 meses** — é justamente isso que a banca explora.

PEGADINHA CLÁSSICA

Rotavírus tem janela rígida: 1ª dose entre **1 mês e 15 dias** e **3 meses e 15 dias**; 2ª até **7 meses e 29 dias** (limites conforme o calendário vigente). Perdida a janela, **perde-se a oportunidade** — não se aplica fora do prazo, pelo risco de invaginação intestinal. É a única do calendário com essa rigidez.

BIZU ESTRATÉGICO

Vias que caem: **BCG** é intradérmica (braço direito); **rotavírus** e **VOP** são orais; **tríplice viral** e **febre amarela** são subcutâneas; **penta**, **VIP**, **pneumo** e **hepatite B** são **IM** (vasto lateral da coxa no lactente). Vacina oral regurgitada não se repete.

4 · Triagem neonatal

TESTE	MOMENTO E FINALIDADE
Teste do pezinho	Entre o 3º e o 5º dia de vida. Detecta doenças metabólicas, genéticas e endócrinas (fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, entre outras).
Teste do olhinho	Reflexo vermelho — detecta catarata congênita, retinoblastoma.
Teste da orelhinha	Emissões otoacústicas — triagem auditiva.
Teste do coraçãozinho	Oximetria de pulso — cardiopatias congênitas críticas.
Teste da linguinha	Avaliação do frênulo lingual.

BIZU ESTRATÉGICO

A data do **pezinho** é **campeã: 3º ao 5º dia**. Nem antes (precisa de tempo de alimentação proteica para detectar fenilcetonúria), nem muito depois (atrasa o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, cujo tratamento precoce evita deficiência intelectual). A janela tem razão fisiológica.

5

Planejamento familiar e aborto legal

Direitos, métodos e os critérios que a lei define.

5 · Planejamento reprodutivo

MÉTODO	CARACTERÍSTICA
Comportamentais	Tabelinha, muco cervical, temperatura basal, coito interrompido. Baixa eficácia.
Barreira	Preservativo masculino e feminino, diafragma. Só o preservativo previne IST.
Hormonais	Pílula combinada, minipílula (progestágeno — segura na amamentação), injetáveis, implante.
DIU	Cobre (não hormonal, até 10 anos) e hormonal (levonorgestrel).
Definitivos	Laqueadura e vasectomia.
Emergência	Levonorgestrel — quanto mais precoce, mais eficaz ; até 72h (podendo estender a 120h com menor eficácia).

BIZU ESTRATÉGICO

Na amamentação, o método hormonal de escolha é o de **progestágeno isolado** (minipílula) — o **estrogênio reduz a produção de leite**. Alternativa que indica pílula combinada para lactante está errada. E lembre: **só o preservativo protege contra IST — dupla proteção.**

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Sobre a **contracepção de emergência**: ela age principalmente **inibindo ou retardando a ovulação**. Não é abortiva — não interrompe gravidez já estabelecida. Esse é um ponto que a prova cobra tanto no aspecto técnico quanto no ético.

5 · Aborto legal

No Brasil, a interrupção da gestação é permitida em **três situações**:

AS TRÊS HIPÓTESES LEGAIS

- ◆ **Risco de vida para a gestante** (aborto necessário/terapêutico).
- ◆ **Gravidez resultante de estupro** (aborto sentimental/humanitário).
- ◆ **Anencefalia fetal** — reconhecida pelo STF (ADPF 54, 2012).

PEGADINHA CLÁSSICA

Pontos que caem: nos casos de **estupro**, não se exige **boletim de ocorrência**, **laudo do IML** nem **autorização judicial** — basta o relato da mulher, com consentimento. Exigir esses documentos é **barreira ilegal**. E o profissional pode alegar **objeção de consciência**, *exceto* quando houver risco de vida ou ausência de outro profissional — a mulher não pode ficar desassistida.

6

Adolescente, adulto e idoso

Cada fase tem sua vulnerabilidade — e sua avaliação.

6 · Saúde do idoso

O idoso é o grupo que mais cresce no Brasil. A avaliação aqui é **funcional**, não apenas diagnóstica.

ITEM	CONTEÚDO
Avaliação funcional	AVD (atividades básicas: banho, vestir-se, alimentar-se) e AIVD (instrumentais: cozinhar, telefone, finanças, medicação).
Síndromes geriátricas — os “gigantes”	Instabilidade postural (quedas), imobilidade, incontinência, incapacidade cognitiva, iatrogenia.
Vacinas do idoso	Influenza anual , Covid-19 semestral , dT (reforço a cada 10 anos), pneumo 23 (situações específicas), hepatite B, febre amarela e tríplice viral conforme histórico.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a apresentação da doença no idoso é **atípica** — e isso mata: a reserva fisiológica reduzida faz a doença se manifestar por vias inespecíficas. Uma infecção urinária no idoso pode se apresentar como **confusão mental aguda ou queda**, sem febre e sem disúria. Um infarto pode vir como dispneia. Por isso, **alteração súbita do comportamento no idoso é sinal de doença aguda até prova em contrário** — não é “coisa da idade”.

BIZU ESTRATÉGICO

Prevenção de **quedas** é campeã: ambiente (tapetes soltos, iluminação, barras de apoio, piso seco), calçado adequado, revisão de **polifarmácia** (sedativos e anti-hipertensivos aumentam o risco) e avaliação de acuidade visual. Queda no idoso não é acidente — é **evento sentinela**.

◆ Adolescente

BIZU ESTRATÉGICO

Atendimento ao adolescente: tem direito a **privacidade e confidencialidade**, podendo ser atendido **desacompanhado**. O sigilo só é quebrado em risco de vida ou situações que exijam intervenção. Vacinas da faixa: **HPV (dose única, 9–14 anos)**, **meningo ACWY (11–14)**, **dengue (10–14)**, dT, hepatite B e tríplice viral conforme histórico.

7

Síntese

As atualizações e os números que decidem.

7 · Revisão rápida do eixo

GESTANTE E PUERPÉRIO

- ◆ Pré-natal: mínimo **6 consultas**; enfermeiro **pode** realizar no risco habitual; não há alta.
- ◆ Vacinas: **dTpa a partir da 20ª semana em cada gestação**; influenza; covid; **VSR (novidade)**.
- ◆ Vírus vivo é contraindicado na gestação (febre amarela é exceção avaliada).
- ◆ Iminência de eclâmpsia: **cefaleia + escotomas + epigastralgia**. Sulfato de Mg: vigiar reflexo, FR e diurese; antídoto = **gluconato de cálcio**.
- ◆ 4º período (Greenberg) = **1ª hora**, maior risco de hemorragia. Causa nº 1: **atonía**. Os **4 T**.

ALEITAMENTO E CRIANÇA

- ◆ Exclusivo **não admite nem água**; até **6 meses**, complementado até **2 anos**.
- ◆ Leite **posterior** = gordura e ganho de peso. Esvaziar uma mama antes de trocar.
- ◆ Contraindicações definitivas: **HIV, HTLV, galactosemia**. Hepatite e TB **não** contraindicam.
- ◆ **Calendário 2026**: meningoc **ACWY aos 12 meses** e 11–14 anos; **HPV dose única (9–14)**; **dengue (10–14)**; influenza **trivalente**; covid infantil.
- ◆ Pezinho: **3º ao 5º dia**. Rotavírus tem **janela rígida**.

PLANEJAMENTO, ABORTO LEGAL E IDOSO

- ◆ Lactante: **progestágeno isolado** (estrogênio reduz o leite). Só preservativo previne IST.
- ◆ Aborto legal: **risco de vida, estupro e anencefalia**. No estupro, **não** se exige BO nem autorização judicial.
- ◆ Idoso: avaliação **funcional** (AVD/AIVD); doença tem apresentação **atípica**; covid **semestral**.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) dizer que o pré-natal é privativo do médico; (2) usar **calendário desatualizado** (meningo C aos 12 meses, HPV em 2 doses, tetravalente); (3) achar que o exclusivo admite água; (4) contraindicar amamentação por hepatite ou TB; (5) exigir boletim de ocorrência no aborto por estupro; (6) suspender a mamada na mastite. Domine essas seis e o eixo é seu.

“Neste eixo, estudar por material velho não é estudar menos. É estudar errado.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · CICLOS DE VIDA

Conteúdo conferido nas fontes oficiais: Calendário Nacional de Vacinação 2026 (criança, adolescente, adulto, idoso e gestante), Caderneta da Gestante e Guia de Atenção à Saúde da Gestante do Ministério da Saúde. O calendário vacinal é revisado anualmente —
confirme a versão do ano antes da prova.